

La CBT-E (Terapia Cognitivo-Conductual Mejorada, Fairburn et al.) es el abordaje con mayor evidencia para TCA en adultos. Es transdiagnóstica: no trata un diagnóstico específico sino los mecanismos cognitivos y conductuales que mantienen cualquier TCA. Alrededor de la mitad a dos tercios de los pacientes outpatients logran reducción significativa de la psicopatología al finalizar el tratamiento, con efectos sostenidos a un año.

Dos versiones según complejidad

CBT-E Focalizada (20 sesiones)

- IMC > 17.5.
- Trata exclusivamente los mecanismos del TCA.
- Indicada para BN, TPA y formas atípicas con peso normal.
- Sesión semanal salvo primeras semanas (bisemanal).

CBT-E Ampliada (hasta 40 sesiones)

- Incluye IMC bajo (AN) y casos complejos.
- Agrega módulos para: perfeccionismo clínico, baja autoestima nuclear, dificultades interpersonales, intolerancia emocional.
- La extensión se decide a partir de la Fase 2 (semana 4–8).

Estructura del tratamiento

Fase 1 — Semanas 1–4. Evaluación, psicoeducación y compromiso con el cambio. Inicio del autorregistro diario. Regularización de la alimentación: 3 comidas + 2–3 colaciones planificadas. Construcción de la conceptualización compartida del caso.

Fase 2 — Revisión (semanas 4–8). Revisión del progreso. Identificación de barreras. Decisión sobre formato (focalizado vs. ampliado). Incorporación de módulos adicionales si corresponde.

Fase 3 — Semanas 8–16. Trabajo sobre los mecanismos cognitivos centrales: sobrevaloración del peso y la forma, restricción cognitiva, conductas de comprobación del cuerpo y evitación corporal, episodios de atracón, conductas compensatorias.

Fase 4 — Semanas 16–20. Prevención de recaídas. Consolidación de cambios. Plan de mantenimiento. Identificación de señales de alerta personales.

Mecanismos cognitivos centrales a trabajar

Cogniciones nucleares

- Sobrevaloración del peso y la forma corporal.
- Reglas dietéticas rígidas e inflexibles.
- Restricción cognitiva (preocupación constante).
- Baja autoestima nuclear basada en la apariencia.
- Perfeccionismo clínico.

Conductas a trabajar

- Restricción alimentaria.
- Conductas compensatorias (purgas, ejercicio excesivo).
- Comprobación y evitación corporal.
- Episodios de atracón.
- Aislamiento social ligado al TCA.

■ La CBT-E requiere entrenamiento específico. Esta ficha es una guía de referencia, no un sustituto de la supervisión ni de la formación en el protocolo. El autorregistro diario de comidas es la herramienta fundacional de toda la intervención y no puede omitirse.